

Desgarros perineales de tercer y cuarto grado

Información para el paciente · Desgarros graves del parto — reparación y curación

WARWIKI

Durante el parto vaginal, la zona entre la vagina y el ano (el perineo) puede desgarrarse. Un desgarro de **tercer grado** llega al músculo del esfínter anal; uno de **cuarto grado** lo atraviesa hasta el revestimiento del recto. Juntos se llaman **OASIS**. Se reparan con cuidado justo después del parto y, con buenos cuidados, la mayoría de las mujeres sanan bien.

Qué pasó

El **esfínter anal** es el anillo de músculo que retiene los gases y las heces. Un desgarro grave afecta este músculo, por eso importan la reparación cuidadosa y el seguimiento — para proteger su control intestinal a largo plazo. Estos desgarros no son culpa suya ni los causó algo que usted hizo.

La reparación

La reparación se hace poco después del parto, casi siempre en un quirófano o sala de partos con buena anestesia (a menudo raquídea o epidural). El cirujano reconstruye los tejidos **por capas** — reconectando el músculo del esfínter y, en los desgarros de cuarto grado, el revestimiento del recto — con puntos reabsorbibles. Recibirá antibióticos y un plan para el dolor y el cuidado intestinal.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Perineo

La zona entre la vagina y el ano.

OASIS

Lesión obstétrica del esfínter anal — un desgarro de 3.er o 4.º grado.

Esfínter anal

El anillo de músculo que controla los gases y las heces.

Tercer grado

Un desgarro que llega al músculo del esfínter anal.

Cuarto grado

Un desgarro que cruza el esfínter hasta el revestimiento del recto.

Ablandador de heces

Medicina para mantener las heces blandas y no pujar al sanar.

Fisioterapia del suelo pélvico

Terapia para recuperar fuerza y coordinación tras la curación.

¿TENDRÉ PROBLEMAS DURADEROS? La mayoría de las mujeres sanan bien y recuperan el control normal. Una minoría nota dificultad para retener gases o heces, por eso importan el seguimiento y la fisioterapia del suelo pélvico — y existen tratamientos eficaces si los síntomas persisten. Avise a su equipo de cualquier escape en vez de esperar.

Curación y autocuidado

- 1 **Mantenga las heces blandas** — tome el ablandador recetado, beba líquidos y coma fibra para no pujar.
- 2 **Dolor e higiene** — use el analgésico recetado, enjuague con agua tibia tras ir al baño y mantenga la zona limpia y seca.
- 3 **Descanse y retome poco a poco** — no levante más peso que su bebé; espere mejoría gradual en semanas.
- 4 **Fisioterapia del suelo pélvico** — ayuda a recuperar fuerza cuando la curación inicial ya avanza.

Seguimiento y partos futuros

- Le revisarán cómo sanó la reparación y su control intestinal.
- Hable sobre **partos futuros** — su equipo le aconsejará el modo de parto más seguro la próxima vez.

Llame a su equipo si tiene:

- **Fiebre, más dolor o flujo de mal olor** (posible infección)
- La herida parece **abrirse**
- **Escape de gases o heces**, o nueva dificultad para controlarlos
- Estreñimiento grave o no poder defecar

Bueno saber

- Siéntese cómoda (un cojín ayuda) y use hielo al inicio para la hinchazón.
- No introduzca nada en el recto (sin supositorios ni enemas) salvo que su equipo lo indique.

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un desgarro de 3.er o 4.º grado (OASIS) afecta el esfínter anal y se repara por capas justo tras el parto.
2. Mantenga las heces blandas, cuide la herida y haga fisioterapia del suelo pélvico — la mayoría sana bien.
3. Informe cualquier escape de gases o heces, fiebre o herida que se abra — la ayuda temprana mejora los resultados.